

ACTUACIÓN EN URGENCIAS ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

ESPERANZA SOTO RUEDA.
MÉDICA ESPECIALISTA MFYC.
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITAL DE MONTILLA.



1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO.



- ▶ **OMS (1996)**→ Violencia contra las mujeres → Problema de salud pública.
- ▶ Ley Orgánica 1/**2004**, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (en adelante LIVG):
 - ▶ **La violencia física, psicológica o sexual ejercida sobre las mujeres “por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia” tiene la consideración de DELITO.**
- ▶ **Pacto de Estado** en materia de Violencia de Género (2018-2022): amplía los mecanismos de acreditación de las situaciones de violencia de género, y fortalece la tutela judicial y el acceso a la justicia.
- ▶ 2025 se realiza **ACTUALIZACIÓN** en Andalucía para PROTOCOLO DE DETECCIÓN TEMPRANA DE CASOS DE VG. Creación e implementación de los cuestionarios **WAST (SENSIBLE) Y AAS (ESPECÍFICO)**

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO.



- Según el Ministerio de Igualdad durante el año **2024** se registran **48 mujeres y 9 menores** asesinados por Violencia de Género en España, siendo un total de 32 menores los que quedan huérfanos durante este año.
- En **2024** en España se realizan **199.094 denuncias por VG**.
- **Más de 1333 víctimas mortales desde que contabilizamos en 2003.**

1. Evolución del número de mujeres víctimas mortales por violencia de género en España. Años 2003 a 2024.



1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO.



- ▶ Mujeres que sufren maltrato buscan atención en **urgencias 1,5 y 3 veces más que las que no lo están.**
- ▶ En muchas ocasiones los servicios de **Urgencias son el primer punto de contacto** con el sistema sanitario de las mujeres que sufren violencia de género.
- ▶ De ellos solo se diagnostican de un **5-15%** de todos los casos.
- ▶ 45% indicó personal sanitario trató la lesión sin preguntar cómo, el 56% aceptó con facilidad explicación falsas.
- ▶ Un **66% de los profesionales no se plantea la VG como diagnóstico diferencial.**

2. TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.



- ▶ **VIOLENCIA FÍSICA:** bofetadas, golpes, palizas, quemaduras...
- ▶ **VIOLENCIA PSICOLÓGICA:** amenazas, insultos, privatización de libertad, chantaje, omisión de cuidados (grupos vulnerables...)
- ▶ **VIOLENCIA SEXUAL:** Imposición a la mujer un comportamiento sexual en contra de su voluntad mediante intimidación, coacción..
- ▶ **VIOLENCIA ECONÓMICA:** privar de forma intencionada a la mujer de recursos.
- ▶ **VIOLENCIA DE CONTROL:** Aislamiento de la mujer de sus familiares, amistades, recursos financieros, empleo, educación...
- ▶ **VIOLENCIA SIMBÓLICA:** emisión de mensajes, iconos, desigualdad y discriminación de la mujer en sociedad.
- ▶ **CIBERVIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES:** Ciberacoso, ciberamenazas..
- ▶ **VIOLENCIA VICARIA:** el maltratador utiliza a los hijos para causar daño a su pareja/expareja.

3.INDICADORES DE SOSPECHA DE MALOS TRATOS (ISMT).



Síntomas psicológicos frecuentes (síntomatología ansiosa)

- Falta de aliento o sensación de ahogo.
- Sensación de pérdida de conciencia, mareos, inestabilidad.
- Sensación de palpitaciones, temblor o sacudidas.
- Sudoración, sofocación, y/o escalofríos.
- Dolor precordial.
- Parestesias en diferentes partes del cuerpo.
- Miedo a morir, a volverse loca, a perder el control.
- Hipervigilancia.
- Trastornos de estrés postraumático.
- Trastorno de estrés agudo.

Síntomas psicológicos frecuentes (síntomatología depresiva)

- Baja autoestima, sentimiento de culpa o desesperanza.
- Intento de suicidio.
- Labilidad emocional.
- Llanto fácil.
- Somatizaciones.
- Abuso de psicofármacos.
- Pérdida de energía, fatiga y falta de concentración.
- Dificultad para tomar decisiones y resolver problemas, agotamiento psíquico.
- Escasas relaciones sociales, poco comunicativa.
- Escasas habilidades sociales.
- Verbalizaciones negativas, engañosas, e incoherentes.
- Poco apetito o voracidad.

Indicadores lesiones físicas

- Contusiones, hematomas y heridas que envuelven la cara, labios, cuello, espalda.
- Hematomas en distintos estadios evolutivos.
- Rotura traumática de tímpano.
- Fractura de huesos por mecanismos atípicos.
- Fractura de cráneo, nariz, mandíbula.
- Quemaduras circulares, longitudinales o con forma de algún objeto (cigarros, plancha, etc.). Quemaduras en zonas poco accesibles.
- Cortes y pinchazos. Mordeduras humanas.
- Arrancamiento de pelo.
- Varias lesiones no típicas en corto periodo de tiempo.
- Problemas físicos o necesidades médicas no atendidas como heridas sin curar, infectadas.
- El mecanismo de producción de la lesión que describe no parece habitual en lesiones similares.

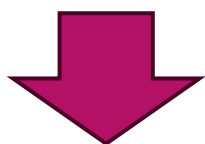
Indicadores gineco-obstétricos	- Nerviosismo excesivo en la toma de flujo para citología, sin lograr que la mujer se relaje. - Objeciones y dificultad o dolor ante el examen pélvico. - Vaginismo que impide introducir el espéculo. - Lesiones en vulva con heridas, hematomas o desgarros perineales cuyas explicaciones son incoherentes. - Dispareunia, dolor pélvico, dismenorrea. - Infecciones ginecológicas de repetición. - Anorgasmia. - Infecciones de transmisión sexual (ITS) no justificables con las prácticas sexuales referidas. - Mastalgia no justificada por mamas fibroquísticas. - Demanda repetida de métodos anticonceptivos de emergencia argumentando frecuentes incidentes. - Embarazo en la adolescencia. Embarazos no deseados. Ausencia de control de fecundidad (muchos embarazos). - Historia de abortos repetidos. Consulta frecuente por disminución de la percepción de movimientos del bebé. Sangrado vaginal durante embarazo. - Lesiones en genitales, abdomen o mamas durante los embarazos. Visualización de hematomas en lugares no compatibles con caídas. - Problemas en la recuperación puerperal.	Indicadores de comportamiento del hombre	- No quiere dejarla sola con el personal sanitario. - Habla por ella, la interrumpe continuamente. - Le grita o hace comentarios negativos de su apariencia o comportamiento, la pone en evidencia, criticando su forma de hacer las cosas, a su familia, a sus amistades o su trabajo. - Controla la documentación o el teléfono de ella. - Solicita o intenta acceder al historial clínico de ella. - Manifiesta actitudes paternalistas: “sabe y resalta lo que es mejor para ella”. - Abuso de alcohol o drogas (El consumo de alcohol y otras sustancias puede agravar la situación de violencia, pero de forma aislada no es un indicador de sospecha).
		Indicadores en situaciones de mayor vulnerabilidad para mujeres con discapacidad	- Depresión, dificultad en la comunicación e interrelación. - Inseguridad, baja autoestima. - Estado de sedación, nerviosismo. - Disfunción motora ajena a la discapacidad; deterioro de la capacidad física residual. - Miedo a relacionarse con otras personas. - Excesiva dependencia de terceras personas. - Escasa o nula participación en actividades familiares o sociales. - Desnutrición, frecuentes enfermedades ajenas a la discapacidad. - Vestuario inadecuado en relación al tiempo atmosférico y a la discapacidad de la persona, ropa sucia. - Largos periodos sin atención por parte de la pareja. - Problemas físicos agravados por falta de tratamiento.
Indicadores de comportamiento de la mujer	- Se muestra ansiosa, evasiva o distraída, evitando el contacto visual. - Sentimiento de vergüenza y/o culpa. - Miedo a hablar delante de la pareja. - Actitud sumisa ante la pareja, buscando constantemente su aprobación. - Contradicción entre su versión de lo ocurrido y la que da la pareja, o cambia su versión cuando está sola. - Vestimenta que puede indicar la intención de ocultar las lesiones. - Falta de cuidado personal. - Justifica sus lesiones o les quita importancia. - En proceso de separación o divorcio.	Factores de riesgo en situaciones de mayor vulnerabilidad para las mujeres por proceder de otros países o estar desplazadas	- Ausencia de redes de apoyo familiar y social. - Mujeres recién llegadas al país. - Barrera idiomática que dificulta la expresión de sus problemas. - Situación de irregularidad administrativa. - Dependencia económica o situación laboral precaria. - Desconocimiento de los recursos.

4. ALGORITMO DE ACTUACIÓN EN URGENCIAS HOSPITALARIAS.

► TRIAJE:

P3 → ISMT/CMT

P1-P2 SEGÚN CLÍNICA



CONSULTA DE
BANALES/SALA DE
CURAS 2.



4. ALGORITMO DE ACTUACIÓN EN URGENCIAS HOSPITALARIAS.



VALORACIÓN CLÍNICA, SOCIAL Y DE LA SITUACIÓN DEL MALTRATO

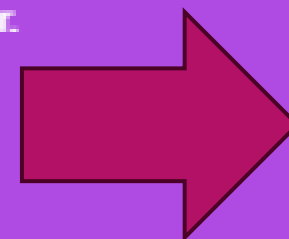
- ✓ Valoración de las lesiones físicas y psicológicas, de la situación emocional y social.
- ✓ Valoración del tipo, duración e intensidad del maltrato.
- ✓ Valoración de fase del proceso de cambio en que se encuentra la mujer.
- ✓ Detectar Situaciones de Peligro Extremo.

INTERVENCIÓN. Planes de Actuación según:

- ✓ Situación del maltrato.
- ✓ Tipo, duración e intensidad del maltrato.
- ✓ Fase del proceso del cambio.
- ✓ Situaciones de Peligro Extremo.
- ✓ El contexto asistencial en el que se produce (Urgencias Extrahospitalarias/ Hospitalarias).

ANOTAR EN HISTORIA CLÍNICA las siglas CMT

- ✓ Anotar al Alta, Código CIE-10 en "Juicios Clínicos" o "Diagnóstico".



- ▶ ¿Existen Índices de Sospecha de Malos Tratos (ISMT)? SÍ/NO
- ▶ ¿Reconoce sufrir malos tratos? SÍ/NO
- ▶ ¿Se encuentra en Situación Objetiva de Riesgo? SÍ/NO
- ▶ ¿Se encuentra en Peligro Extremo? SÍ/NO

SITUACIONES OBJETIVAS DE RIESGO (SOR)



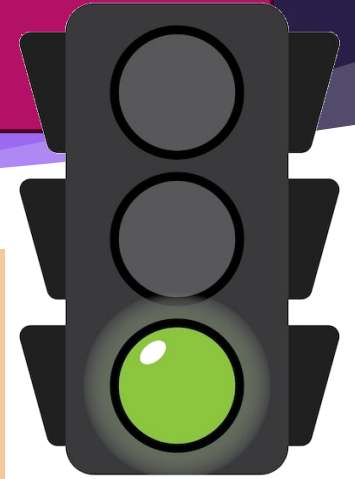
- ▶ Amenazas a la integridad física/psíquica/sexual de los menores.
- ▶ Amenazas de muerte reiteradas a la mujer o a menores convivientes.
- ▶ Malos tratos a los hijos, hijas u otros miembros de la familia.
- ▶ Los menores presencian el maltrato a la mujer.
- ▶ Acuden familiares o allegados a pedir ayuda ante la imposibilidad de hacerlo la mujer.
- ▶ En el domicilio existen armas de fuego o blancas que se utilizan con fines intimidatorios.
- ▶ Cuando la mujer amenace con suicidarse o lo haya intentado.
- ▶ Constatación de aumento de la gravedad de las agresiones y/o su frecuencia.
- ▶ Mujer extranjera, con falta de apoyo familiar o Ap de violencia de género.
- ▶ Mujer que resida en un lugar aislado.
- ▶ Mujer con discapacidad física-psíquica o sensorial o con enfermedad crónica invalidante...
- ▶ Maltratos con discapacidad, trastorno mental grave,...
- ▶ Maltratos con celos extremos, control obsesivo de las actividades diarias y vida de la mujer...
- ▶

SITUACIONES DE PELIGRO EXTREMO

- ▶ Lesiones **graves** que requieran ingreso hospitalario.
- ▶ El maltratador **no respeta la Orden de Alejamiento**.
- ▶ Aumento de la intensidad y frecuencia de la violencia.
- ▶ Amenazas o intentos **de homicidio** a la mujer y a sus hijos.
- ▶ Amenazas o intentos de **suicidio** de la mujer.
- ▶ Consumo de **alcohol y drogas** por parte del maltratador.
- ▶ Agresiones durante el **embarazo, el posparto o la lactancia**.
- ▶ **Abusos sexuales repetidos**.
- ▶ **Comportamiento violento** fuera del hogar.
- ▶ El maltratador la ha **retenido** contra su voluntad.
- ▶ Retirada de la denuncia, renuncia a la Orden de Protección o reanudación de la convivencia.
- ▶ Verbalización de “**miedo**” por parte de la mujer.
- ▶ **LA PERCEPCIÓN DE PELIGRO POR PARTE DE LA MUJER, TANTO DE ELLA COMO PARA OTROS MIEMBROS DEL ENTORNO FAMILIAR, SE DEFINE POR SI SOLA COMO DE PELIGRO EXTREMO.**

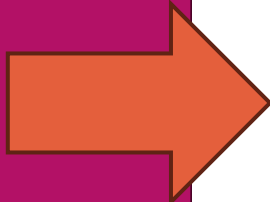


4.1. MUJER QUE PRESENTA ISMT PERO NIEGA MALOS TRATOS Y NO PRESENTA SOR.



- ▶ Detección indirecta aplicando **indicadores de sospecha**.
- ▶ Registrar como **sospecha de malos tratos (ISMT)**.
- ▶ Apertura de historia clínica específica de VG (DIRAYA).
- ▶ Informe clínico detallado (**sin comunicar al juzgado**).
- ▶ **Derivación a Atención Primaria en 48 h** con comunicación previa del motivo (habría que gestionarlo con **enfermera de enlace**, ya que no tenemos Trabajador Social).
- ▶ Informar a la mujer de **legislación, red de recursos disponibles y derivación activa al CIM**.

4.2. MUJER QUE PRESENTA ISMT PERO NIEGA MALOS TRATOS Y SÍ PRESENTA SOR.



PARTE A FISCALIA

► FAX AL FISCAL DELEGADO/A
PROVINCIAL CONTRA LA VIOLENCIA
A LA MUJER.

► FAX FISCALIA PROVINCIAL DE
CÓRDOBA-VG 957353123

POSIBLE SUPUESTO DE MALOS TRATOS A MUJER

Datos del personal facultativo

Nombre y apellidos:

Centro sanitario:

Nº de colegiado/a:

Datos personales de la mujer

Nombre y apellidos:

Domicilio:

Fecha nacimiento:

Teléfono de contacto:

Datos en que se funda la posible existencia de un supuesto de malos tratos

—
—
—

Acompañar informes clínicos que existen en el centro por otras asistencias prestadas a la mujer, que puedan ser de relevancia para la autoridad judicial al proporcionar información acerca de la habitualidad del maltrato:

—
—
—

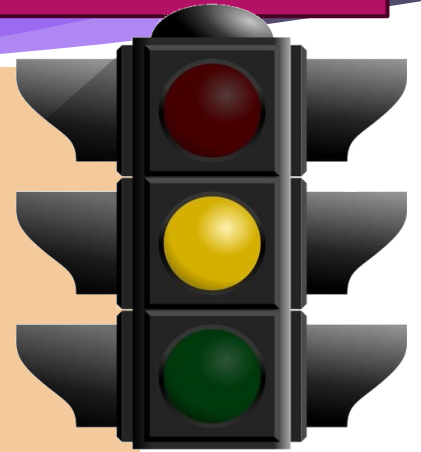
Lo que pongo en su conocimiento al amparo de lo previsto en el Art. 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y por si considera oportuno la incoación de diligencias de comprobación.

CNP o Nº Colegiado

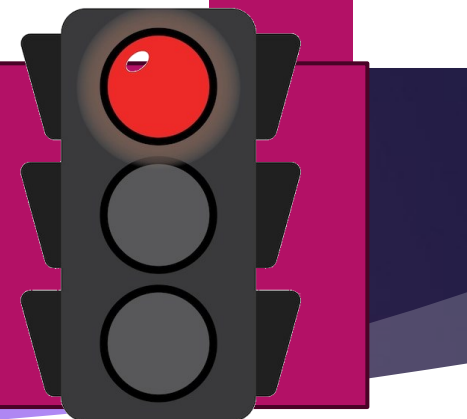
LUGAR Y FECHA FIRMA

4.3. MUJER QUE PRESENTA CMT PERO NO SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE PELIGRO EXTREMO.

- ▶ Valoración de riesgo (clasificación avanzada).
- ▶ **Confirmación de malos tratos (CMT):**
 - ▶ Apertura de historia clínica específica (DIRAYA).
 - ▶ **¡¡REALIZAR PARTE AL JUZGADO!!**
 - ▶ Valoración médica completa.
- ▶ Coordinación **con Trabajo Social/supervisor de guardia/enfermero de enlace:** derivación a dispositivo de seguimiento previo consentimiento informado (EAM, CIM, SAVA) y AP.
- ▶ Informar a la mujer de **derecho a denuncia**.
- ▶ Valorar necesidad de **derivación a otros dispositivos** (por ej. Salud Mental).
- ▶ Actuaciones necesarias con personas convivientes e hijos/as.



4.4. MUJER QUE PRESENTA CMT Y SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE PELIGRO EXTREMO.



- ▶ **Riesgo vital o físico grave.**// Riesgo para **menores o dependientes**// **Aislamiento o situación de desprotección.**
- ▶ **Atención interdisciplinar:** problemas físicos, psicológicos y sociales.
- ▶ Avisar a **Supervisor/enfermero de enlace.**
- ▶ **INTERVENCIÓN INMEDIATA:**
 - ▶ Acompañamiento constante.
 - ▶ **ACTIVAR A FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD.**
 - ▶ **HACER PARTE AL JUZGADO.**
 - ▶ **DERIVACION AL CIM PREVIO CONSENTIMIENTO INFORMADO.**
 - ▶ SI NO DISPONE DE LUGAR SEGURO, SE LLAMARÁ A TELÉFONO **24 HORAS DE IAM (900.200.999)** PARA SOLICITAR **CENTRO DE ACOGIDA INMEDIATA.**
 - ▶ VALORAR NECESIDAD DE **DERIVACION A OTROS DISPOSITIVOS.**
 - ▶ ACTUACIONES NECESARIAS CON **HIJOS/AS Y CONVIVIENTES.**



**PLAN D Situación con
peligro extremo**

**PLAN C Situación sin
peligro extremo**

**PLAN B Situación
con riesgo objetivo**

**PLAN A Situación
sin riesgo objetivo**

Registrar **CMT** en Historia Clínica

Registrar **ISMT** en Historia Clínica

Llamar al Centro
Coordinador de Urgencias
y Emergencias para
activación FYCSE

Emisión parte al Juzgado

Comunicación a
Fiscalía

Derivación a EAM o Trabajo Social AP

Derivación GRUSE

Atención integral/interdisciplinar de los problemas de la mujer
Valoración de hijos y personas dependientes y actuaciones que procedan
Derivación a recursos externos si procede

5. INDICADORES DE CALIDAD EN LA CUMPLIMENTACIÓN DEL PARTE AL JUZGADO.



Indicador	Descripción
1. Tiempo de emisión	Parte remitido al juzgado dentro de las 24 h.
2. Cumplimentación completa	Campos obligatorios cubiertos (lesiones, relato, medidas aplicadas).
3. Consistencia clínica y narrativa	Coherencia entre hallazgos y relato; literalidad del testimonio.
4. Archivo y trazabilidad	Registro en historia electrónica y en historia VG.
5. Coordinación interinstitucional	Notificación a recursos sociales, judiciales y de seguimiento.

PARTE AL JUZGADO. APARTADOS 1 Y 2.



1 DATOS DEL CENTRO O SERVICIO SANITARIO										
NOMBRE DEL CENTRO O SERVICIO SANITARIO: Nombre del Centro Sanitario										
DOMICILIO:										
TIPO DE VÍA:		NOMBRE DE LA VÍA: Dirección del Centro Sanitario								
NÚMERO:	LETRA:	KM EN LA VÍA:	BLOQUE:	PORTAL:	ESCALERA:	PLANTA:	PUERTA:	NÚCLEO DE POBLACIÓN:		
PROVINCIA: Provincia		PAÍS:		CÓD. POSTAL: [][][][]		NÚMERO TELÉFONO: Teléfono		FECHA DE LA ASISTENCIA:		HORA (de llegada al centro o servicio sanitario)
2 DATOS DE LA PERSONA LESIONADA										
APELLIDOS Y NOMBRE: Nombre y apellidos de la Mujer										SEXO: ☐ Hombre ☐ Mujer
DNI/NIE/PASAPORTE/TARJETA SANITARIA N°: DNI de la Mujer			FECHA NACIMIENTO:		EDAD:	LUGAR DE NACIMIENTO:			PAÍS DE NACIMIENTO:	
DOMICILIO:										
TIPO DE VÍA:		NOMBRE DE LA VÍA: Dirección de la Mujer								
NÚMERO:	LETRA:	KM EN LA VÍA:	BLOQUE:	PORTAL:	ESCALERA:	PLANTA:	PUERTA:	NÚCLEO DE POBLACIÓN:		
PROVINCIA: Provincia		PAÍS:		CÓD. POSTAL: [][][][]		TELÉFONOS: Teléfono		☐ PERSONA FALLECIDA		
EMBARAZO:		☐ SI ☐ NO	PERSONA CON DISCAPACIDAD:		☐ FÍSICA ☐ INTELECTUAL ☐ SENSORIAL ☐ MENTAL					
¿TIENE PERSONAS MENORES DE EDAD O MAYORES A SU CARGO?: (En caso positivo indicar si son personas menores o mayores y su número)				☐ NO ☒ SI	☒ MENORES DE EDAD ☐ PERSONAS MAYORES		NÚMERO:		2	

PARTE AL JUZGADO. APARTADO 3.



3 CAUSA PRESUMIBLE DE LAS LESIONES (O DEL FALLECIMIENTO)						
☒ MALTRATO A PERSONAS:						
☒ Violencia de género	☒ Física	☒ Psicológica	☐ Sexual			
☐ Maltrato infantil	☐ Físico	☐ Emocional	☐ Sexual	☐ Negligencia		
☐ Maltrato personas mayores	☐ Físico	☐ Psicológico	☐ Sexual	☐ Negligencia		
☐ AGRESIÓN:	☐ Física	☐ Verbal	☐ Sexual	☐ Otras (especificar)		
☐ ACCIDENTE:	☐ Doméstico	☐ Escolar	☐ Laboral	☐ Tráfico	☐ Otras (especificar)	
☐ ANIMALES:	☐ Mordedura	☐ Arañazo	☐ Lamedura	☐ Otras (especificar)		
☐ INTOXICACIÓN (especificar): _____						
☐ OTRAS CAUSAS (especificar): _____						

SEXO de la persona AGREDIDA	
¿Es una mujer?: SI puede ser violencia de Género	¿Es un hombre?: NO puede ser violencia de género
↓	
La persona AGREDIDA CONOCE a la persona AGRESORA	
SI la conoce: SI puede ser violencia de Género	NO la conoce: NO puede ser violencia de género
↓	
SEXO de la persona AGRESORA	
Hombre: SI puede ser violencia de género	Mujer: NO puede ser Violencia de género
↓	
RELACIÓN con la persona AGRESORA	
Pareja actual o expareja: SI puede ser violencia de Género	Otro tipo de relación: NO puede ser violencia de Género

PARTE AL JUZGADO. APARTADO 4



4 DATOS RELACIONADOS DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA ASISTENCIA, SEGÚN MANIFIESTA:			
DIRECCIÓN/LUGAR DE LOS HECHOS O DEL INCIDENTE: <u>Dirección</u>			
PARA LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, MATRATO O AGRESIONES: ¿CONOCE A LA/S PERSONA/S AGRESORA/S? ☒ SI ☐ NO		NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S AGRESORA/S: <u>Agresor</u>	SEXO: ☒ H ☐ M
EN CASO DE RESPUESTA AFIRMATIVA CONSIGNAR:	DIRECCIÓN: <u>Dirección del agresor</u>		TELÉFONO: <u>teléfono</u>
	RELACIÓN/PARENTESCO DE LA/S PERSONA/S AGRESORA/S ☒ Pareja actual ☐ Expareja ☐ Pareja del padre o de la madre ☐ Hermano/a ☐ Tío/a y otro familiar ☐ No familiar ☐ No especifica ☐ Hijo/a ☐ Padre/Madre		
OTRAS VÍCTIMAS EN EL MISMO INCIDENTE (consignar nombre y apellidos, relación o parentesco con la persona lesionada) ☒ NO ☐ SI			
TESTIGOS DEL INCIDENTE (consignar nombre y apellidos, relación o parentesco con la persona lesionada): <u>No</u>			
LA PERSONA ACUDE: ☐ SOLA ☒ ACOMPAÑADA (consignar nombre y apellidos, relación de parentesco con la persona lesionada): <u>Hermana</u>			
DESCRIBIR CÓMO HAN OCURRIDO LOS HECHOS, UTILIZANDO CUANDO SEA POSIBLE (y con entrecorillado) LAS MISMAS PALABRAS DE LA PERSONA LESIONADA: <u>La paciente refiere inicio de discusión al llegar a casa tras estar con unas compañeras del trabajo tomando un café.</u> <u>"Cuando discutimos hay muchas veces que termina dándome en bofetón. A veces me sujeta las manos mientras me grita cosas como "cállate", "asquerosa", "no vales para nada". Hoy me ha abofeteado y arañado el cuello"</u>			

PARTE AL JUZGADO. APARTADOS 5-10.

5 LESIONES QUE PRESENTA (describir el tipo de lesiones, localización y posible fecha de las mismas)

Presenta equimosis de forma redondeada de 2 cm de longitud de color negra en zona suprorbitaria dcha, cinco escoriaciones lineales de color rojo claro de reciente aparición en parte anterior dcha del cuello y equimosis verdosa oscura de 3 cm de longitud en parte anterior de antebrazo dcho de aspecto antiguo. Refiere insultos, menosprecios, humillaciones, descalificaciones y amenazas de llevarse a los niños

6 ESTADO PSIQUICO Y EMOCIONAL (describir los síntomas emocionales y la actitud de la persona)

Durante la entrevista se muestra algo confusa, tendente al sollozo, inquieta e hipervigilante con todo lo que le rodea en la consulta. En varias ocasiones, tiene que interrumpir el discurso para llorar

7 PRUEBAS COMPLEMENTARIAS REALIZADAS Y SOLICITADAS

Rx de columna cervical, craneo y antebrazo dcho: sin patología aguda

8 MEDIDAS TERAPEÚTICAS (incluir medidas profilácticas, tratamiento farmacológico, curas locales, tratamiento quirúrgico, etc....)

Curas de escoriaciones en cuello
Lorazepam 1mg sl

9 PRONÓSTICO CLÍNICO (salvo complicaciones)

☐ LEVE ☒ MODERADO ☐ GRAVE ☐ MUY GRAVE

10 PLAN DE ACTUACIÓN

☐ INGRESO

☒ ALTA

☒ DERIVACION A:

☒ Atención Primaria

☐ Atención Especializada

PARA CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, MALTRATO O AGRESIONES

☒ Información sobre recursos de atención al maltrato

☒ Valoración del riesgo

☒ Plan de seguridad



PARTE AL JUZGADO. APARTADO 11.



11 ANTECEDENTES DE INTERÉS, para casos de violencia de género, maltrato o agresiones	
¿HA SUFRIDO AGRESIONES ANTERIORMENTE? ☒ SÍ ☐ NO Desde cuando: ☐ En el último año ☒ A lo largo de la vida	
EN CASO DE AGRESIONES ANTERIORES SE CONSIGNARÁ:	
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S AGRESORA/S: Agresor	
DIRECCIÓN: Dirección del agresor	TELÉFONO:
RELACIÓN/PARENTESCO DE LA/S PERSONA/S AGRESORA/S ☒ Pareja actual ☐ Expareja ☐ Pareja del padre o de la madre ☐ Hermano/a ☐ Hijo/a ☐ Padre/Madre ☐ Tío/a y otro familiar ☐ No familiar ☐ No especifica	
INDICAR CUÁNDO, DESCRIBIR LAS LESIONES Y EVOLUCIÓN DE LAS MISMAS Desde el primer embarazo	
DENUNCIAS PREVIAS: ☐ SÍ ☒ NO	¿HAY TESTIGOS DE ESOS ATAQUES? En caso afirmativo especificar nombre, apellidos, relación de parentesco con la persona lesionada: ☐ SÍ ☐ NO
¿HABÍA OTRAS PERSONAS LESIONADAS EN ESOS ATAQUES? En caso afirmativo especificar nombre, apellidos, relación de parentesco con la persona lesionada: ☐ SÍ ☒ NO	
¿EXISTE PROCEDIMIENTO ABIERTO? ☐ SÍ ☒ NO	¿EXISTE ORDEN DE ALEJAMIENTO? ☐ SÍ ☒ NO

PARTE AL JUZGADO. APARTADO 12.



12 OBSERVACIONES

OTROS DATOS DE INTERES PARA EL ÓRGANO JUDICIAL (no quiere presentar denuncia; miedo a la/s persona/s agresora/s, a perder la custodia de menores, a la reacción de familiares; precariedad económica, etc...):

No quiere presentar denuncia; miedo a la persona agresora, a perder la custodia de los menores

SE CONTACTA TELEFÓNICAMENTE ☒ SÍ ☐ NO

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR CON QUÉ RECURSO SE CONTACTA, LA HORA DE CADA LLAMADA Y EL RESULTADO DE LAS MISMAS:

- ☐ JUZGADO DE GUARDIA: _____
- ☒ FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD: 15:32 _____
- ☐ SERVICIOS SOCIALES: _____
- ☐ CENTROS DE INFORMACIÓN DE LA MUJER: _____
- ☐ OTROS RECURSOS (especificar): _____
- ☐ SE SOSPECHA QUE LA CAUSA DE LAS LESIONES SEA DIFERENTE A LA QUE REFIERE LA PERSONA.

EQUIPO DE ATENCIÓN A LA MUJER Y FAMILIA

- ▶ **RECURSO DEL SAS DISPONIBLE EN AGS SUR DE CÓRDOBA.**
- ▶ **OBJETIVO:** fortalecimiento y acompañamiento de víctimas, facilitando el acceso a recursos.
- ▶ **Metodología de trabajo:** atención y seguimiento de la mujer de forma presencial y mediante teleasistencia con abordaje biopsicosocial.
- ▶ **TODOS LOS CASOS DE CMT O ISMT serán derivados a EAMF DEL AGS SUR DE CÓRDOBA MEDIANTE GESTIÓN DE CITAS PREFERENTES O URGENTES QUE SERÁN SOLICITADAS POR SUPERVISORES DE GUARDIA DE CENTROS HOSPITALARIOS O REFERENTES DE LOS EBAP DEL AGS SUR DE CÓRDOBA.**
- ▶ **Correo corporativo:** equipovg.cordobasur.acord.sspa@juntadeandalucia.es
- ▶ **TELÉFONOS DE CONTACTO:**
 - Enfermeras:** Verónica León (corporativo 654 567) y Silvia Sánchez (corporativo 654 377)
 - Trabajadora social:** Monserrat (corporativo 654568)

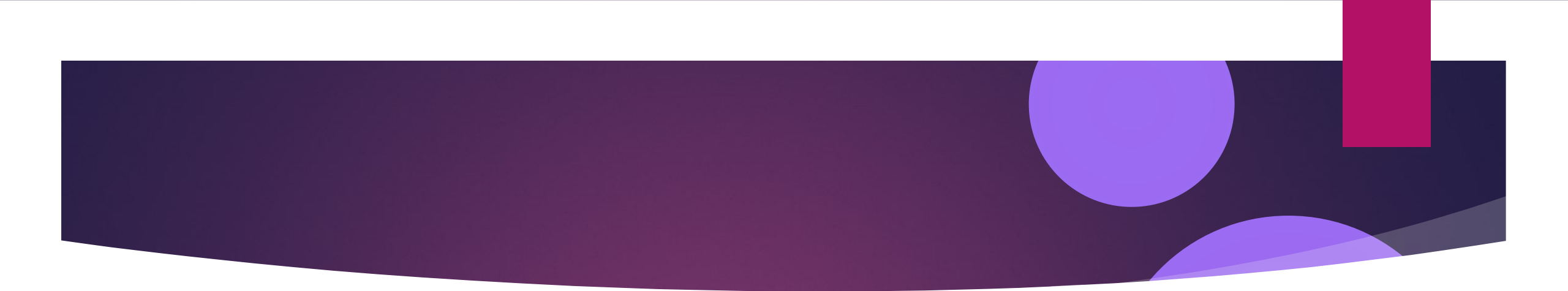
RECURSOS SANITARIOS Y NO SANITARIOS

▶ EQUIPO DE ATENCIÓN A LA MUJER:

- ▶ Tlf. 682 784185 / 682 769449 / 689 387284. equipovg.cordobasur.acord.sspa@juntadeandalucia.es

▶ RECURSOS NO SANITARIOS PRINCIPALES:

- ▶ Delegación Especial del Gobierno contra la violencia sobre la mujer:
 - ▶ **016** (no queda reflejado en la factura de teléfono).
 - ▶ 900166016 (para personas con discapacidad auditiva).
- ▶ Teléfonos de información del Instituto de la Mujer (Estatat):
 - ▶ 900191010
 - ▶ 900152152 (para personas con discapacidad auditiva).
- ▶ Teléfonos de información del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM):
 - ▶ **900 200 999** (incluye programa de atención psicológica 24h/día, información, asesoramiento jurídico, acogida).
 - ▶ **Centro IAM en Córdoba: C/Ollerías, 48. Tlf 957003400. Correo: c.mujer.cordoba.iam@juntadeandalucia.es**
- ▶ Servicio de Emergencias: 112
- ▶ Servicio de Urgencias Sanitarias: 061
- ▶ Policía Nacional: 091
- ▶ Guardia Civil: 062.



**ALGUNOS
EJEMPLOS....**

CASO 1

► Descripción del caso:

Ana, de 28 años, acude a urgencias por una **contusión en el pómulo** derecho. Indica que se **ha caído en la ducha**. Presenta **ansiedad leve, evita el contacto visual** y está **acompañada por su pareja**, que responde por ella constantemente.

► Pregunta: ¿Qué actuación sería la más adecuada en este caso?

- A. Registrar el traumatismo como accidente doméstico y dar el alta sin más intervención.
- B. Indagar en privado con la paciente sobre el origen de la lesión y aplicar indicadores de sospecha.
- C. Emitir parte judicial sin más datos porque “puede ser violencia de género”.
- D. Llamar inmediatamente a la policía.

CASO 1.

► Descripción del caso:

Ana, de 28 años, acude a urgencias por una **contusión en el pómulo** derecho. Indica que se **ha caído en la ducha**. Presenta **ansiedad leve, evita el contacto visual** y está **acompañada por su pareja**, que responde por ella constantemente.

► Pregunta: ¿Qué actuación sería la más adecuada en este caso?

- A. Registrar el traumatismo como accidente doméstico y dar el alta sin más intervención.
- B. Indagar en privado con la paciente sobre el origen de la lesión y aplicar indicadores de sospecha.
- C. Emitir parte judicial sin más datos porque “puede ser violencia de género”.
- D. Llamar inmediatamente a la policía.

CASO 2.

► **Descripción del caso:**

Isabel, de 43 años, refiere en consulta haber **sufrido empujones y amenazas por parte de su expareja** hace dos días. **No presenta lesiones ni signos de riesgo inminente. Acude sola y tranquila**, aunque emocionalmente afectada.

► **Pregunta:**¿Cuál es la actuación prioritaria?

- A. Derivarla directamente a salud mental.
- B. Abrir historia clínica específica de VG y realizar parte al juzgado de guardia.
- C. Solicitar ingreso hospitalario preventivo.
- D. Llamar a un familiar para que la acompañe.

CASO 2.

► **Descripción del caso:**

Isabel, de 43 años, refiere en consulta haber **sufrido empujones y amenazas por parte de su expareja** hace dos días. **No presenta lesiones ni signos de riesgo inminente. Acude sola y tranquila**, aunque emocionalmente afectada.

► **Pregunta:**¿Cuál es la actuación prioritaria?

- A. Derivarla directamente a salud mental.
- B. **Abrir historia clínica específica de VG y realizar parte al juzgado de guardia.**
- C. Solicitar ingreso hospitalario preventivo.
- D. Llamar a un familiar para que la acompañe.

CASO 3.

► **Descripción del caso:**

Rosa, de 36 años, presenta una fractura en el antebrazo. Dice haberse caído, pero la exploración física y la actitud indican sufrimiento y miedo. Hay antecedentes en la historia clínica de urgencias de lesiones previas.

► **Pregunta:** ¿Cómo debe procederse?

- A. Respetar su versión y no intervenir más allá del tratamiento físico.
- B. Forzar verbalización para poder notificar.
- C. Registrar como sospecha, activar la historia de VG y derivar.
- D. Emitir parte judicial obligatorio.

CASO 3.

► **Descripción del caso:**

Rosa, de 36 años, presenta una fractura en el antebrazo. Dice haberse caído, pero la exploración física y la actitud indican sufrimiento y miedo. Hay antecedentes en la historia clínica de urgencias de lesiones previas.

► **Pregunta:** ¿Cómo debe procederse?

► A. Respetar su versión y no intervenir más allá del tratamiento físico.

B. Forzar verbalización para poder notificar.

C. Registrar como sospecha, activar la historia de VG y derivar.

D. Emitir parte judicial obligatorio.

CASO 4.

► **Descripción del caso:**

Miriam, de 51 años, llega desorientada y con hematomas múltiples. Dice que su pareja la ha golpeado esa misma mañana y teme por su vida. Tiene hijos menores en casa. Llega sin acompañamiento.

► **Pregunta:** ¿Cuál es la actuación inmediata?

- A. Derivar a Atención Primaria en 48 horas.
- B. Emitir parte al juzgado, activar FYCS y valorar ingreso.
- C. Esperar a que ella decida si quiere denunciar.
- D. Ofrecer cita para entrevista social posterior.

CASO 4.

► **Descripción del caso:**

Miriam, de 51 años, llega desorientada y con hematomas múltiples. Dice que su pareja la ha golpeado esa misma mañana y teme por su vida. Tiene hijos menores en casa. Llega sin acompañamiento.

► **Pregunta:** ¿Cuál es la actuación inmediata?

► A. Derivar a Atención Primaria en 48 horas.

B. Emitir parte al juzgado, activar FYCS y valorar ingreso.

C. Esperar a que ella decida si quiere denunciar.

D. Ofrecer cita para entrevista social posterior.



ESPERANZA SOTO RUEDA.
MÉDICA ESPECIALISTA MFYC.
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITAL DE MONTILLA.